Клинические рекомендации

# Инородное тело в пищеварительном тракте

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **T18** — Инородное тело в пищеварительном тракте |
| Пациенты | взрослые, дети |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года |
| Разработчик | Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов" ; Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО" |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/710_2 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 3

**2. Клиническая картина и классификация** 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 4

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

**3. Диагностика** 5

3.1 Жалобы и анамнез 5

3.2 Физикальное обследование при поступлении 6

3.3 Лабораторные исследования: анализы крови 6

3.4 Рентгенография 6

3.5 Рентгеноскопия с контрастом 6

3.6 Компьютерная томография 7

3.7 Эндоскопия 7

3.8 Дифференциальная диагностика 7

**4. Лечение** 7

4.1 Сроки эндоскопии 7

4.2 Консервативное ведение 8

4.3 Эндоскопическое лечение 8

4.4 После удаления 10

4.5 Медикаментозная терапия 10

4.6 Хирургическое лечение 11

**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации** 12
5.1 Организация помощи и госпитализация 12
5.2 Реабилитация и профилактика 12
**6. Источник и актуальность** 13
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

## 1. Основные положения

- Инородным телом пищеварительного тракта называют любой объект, проглоченный, введённый в его просвет или образовавшийся в нём, который не может служить пищей.
- При поступлении показан осмотр оториноларинголога для исключения инородного тела полости рта и глотки и осмотр хирурга для выявления признаков перфорации и других осложнений.
- Диагноз устанавливается при обнаружении инородного тела при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании либо во время операции.
- При батарейке, остроконечном предмете или полной обструкции в пищеводе эндоскопическое удаление выполняется экстренно: **лучше в течение 2 часов, не позднее 6**. Остальные инородные тела пищевода, в том числе магниты, удаляют срочно, **в течение 24 часов**.
- Дисковую батарейку у ребёнка, в том числе находящуюся в желудке, удаляют независимо от симптомов, размера и количества: **лучше в течение 12 часов, не позднее 24**.
- Наблюдение без извлечения допустимо, если инородное тело находится вне пищевода, не вызывает симптомов, тупое, инертное и небольшое (**до 2–2,5 см в диаметре или 5 см в длину**).
- Консервативное ведение при батарейках и магнитах противопоказано; эндоскопическое удаление контейнеров с наркотиками не рекомендуется.
- Пациентов госпитализируют в многопрофильный стационар с круглосуточной эндоскопической службой; при аспирации, перитоните, кишечной непроходимости — в отделение реанимации и интенсивной терапии.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определения

Инородное тело пищеварительного тракта — объект органического, неорганического или искусственного происхождения, случайно или намеренно проглоченный, введённый в просвет пищеварительного тракта или образовавшийся в организме, который по составу и (или) расположению не может служить пищей.

Условно инородные тела — пища, желчные камни, паразиты, становящиеся инородным телом при определённых обстоятельствах: вклинение пищевого комка в зону сужения пищевода, миграция желчного камня в просвет кишки, конгломерат паразитов.

**Инородные тела по воздействию на стенку**

| Вид | Определение |
|---|---|
| **Инертные** | без выраженного патологического воздействия на стенку: монеты, мелкие игрушки, клипсы, стеклянные и металлические шарики |
| **Механически активные** | механическое повреждение стенки: иголки, булавки, саморезы, проволока |
| **Физически активные** | выраженное физическое, компрессионное воздействие: магниты |
| **Химически активные** | химические и термические ожоги вплоть до перфорации: дисковые батарейки таблеточного типа |
| **С комбинированным воздействием** | механическое (обтурация, компрессия) и химическое воздействие: безоары, силикагелевые шарики |

Признак Турнера — ощущение инородного тела в гортаноглотке или пищеводе даже после его прохождения в желудок.

### 2.2 Этиология

У детей чаще, чем у взрослых; пик — от 6 месяцев до 6 лет. Самые частые у детей — монеты: через пищевод самостоятельно проходят у 30–60%. Застрявшая в пищеводе дисковая батарейка — угрожающее жизни состояние (трахеопищеводный и трахеоаортальный свищ, медиастинит, абсцесс шеи). Взрослые глотают инородные тела случайно или намеренно (психические заболевания, заключённые), «курьеры» — контейнеры с наркотиками; бывают ятрогенные инородные тела (видеокапсулы, стенты, зубные протезы).

### 2.3 Классификация

1. по происхождению: истинные (проглоченные умышленно, случайно, незаметно; введённые через задний проход; оставленные при вмешательствах; попавшие при травме) и условно инородные тела (вклиненный пищевой комок; желчные камни, безоары, каловые камни; живые инородные тела);
2. по локализации: пищевод (68,4%), желудок (18,9%), тонкая кишка (7,1%), толстая кишка (3%), прямая кишка (2,6%).

1. по количеству: единичные, множественные;
2. по динамике: мигрирующие, свободнолежащие, фиксированные;
3. по величине: мелкие (**до 2–2,5 см в диаметре или до 5 см в длину**), средние (2,5–5 см или до 10 см), крупные (более 5 см или более 10 см);
4. по воздействию: инертные; потенциально агрессивные (контейнеры с наркотиками, хрупкие предметы); агрессивные, в том числе химически (батарейки), физически (магниты, ртуть), механически активные (остроконечные) и комбинированные (безоары, силикагель).

**Рентгеноконтрастность инородных тел**

| Контрастность | Инородные тела |
|---|---|
| **рентгеноконтрастные, хорошо видны на снимке** | истинные рентгенопозитивные инородные тела непищевого происхождения, мясные кости |
| **малоконтрастные и рентгенонегативные, как правило, не видны** | пищевой комок, рыбьи и куриные кости, дерево, пластик, стекло, тонкие металлические предметы |

**Классификация Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии**

| Тип | Примеры |
|---|---|
| **тупые** | монета, пуговица, игрушка; батарейки, магниты |
| **остроконечные** | игла, зубочистка, кость, булавка, осколки стекла; фрагмент зубного протеза, лезвие |
| **длинные** | мягкие (струна, верёвка), твёрдые (зубная щётка, столовый прибор, отвёртка, ручка) |
| **пищевые комки** | с костями или без |
| **другие** | контейнеры с запрещёнными веществами |

### 2.4 Клиническая картина

У детей зона глоточно-пищеводного перехода уже и длиннее, поэтому инородное тело чаще застревает в шейном отделе пищевода. Непищевые инородные тела составляют 75–90%, чаще возникает респираторный синдром.

**Проявления у детей**

1. кашель, одышка, свистящее дыхание, ложный круп;
2. гиперсаливация, слюнотечение, поперхивание, рвота;
3. дисфагия, одинофагия, отказ от еды, ощущение комка в горле.

У части детей симптомов нет до развития осложнений.

**Инородное тело пищевода у взрослых (выраженная картина у 50–68%)**

1. боль по ходу пищевода, в яремной ямке, затылке, спине, эпигастрии;
2. слюнотечение, невозможность проглотить твёрдую и жидкую пищу, дисфагия, срыгивание;
3. одышка; вынужденное положение при инородном теле в виде «якоря».

**Вторичные проявления**

1. лихорадка, обезвоживание, запах изо рта;
2. осиплость голоса;
3. инфильтрация мягких тканей шеи, подкожная эмфизема, пневмоторакс.

10% инородных тел пищевода бессимптомны; «мнимые» инородные тела — 10–15%.

Большинство инородных тел (80–90%) выходит самостоятельно; эндоскопическое удаление требуется в 10–20% случаев, хирургическое вмешательство — менее чем в 1%.

Инородные тела желудка и ДПК проявляются слабо — только крупные, длинные и острые; пролежень и перфорация дают перитонеальные симптомы или забрюшинный инфильтрат. Крупные инородные тела прямой кишки — тенезмы, боль в промежности, кровь в стуле. Отсутствие симптомов не повод отказаться от обследования.

---

## 3. Диагностика

Диагноз подтверждается обнаружением инородного тела при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании либо во время операции. На догоспитальном этапе и при поступлении диагноз основывается на анамнезе и данных осмотра.

### 3.1 Жалобы и анамнез

Тщательная оценка жалоб и детальный анамнез.

**Необходимо выяснить**

1. что проглочено (на снимке монета похожа на дисковую батарейку);
2. сколько прошло времени, когда последний раз ел и пил;
3. пытался ли пациент сам извлечь или «протолкнуть» инородное тело (сухой хлеб);
4. были ли попытки эндоскопического удаления;
5. были ли такие эпизоды; эозинофильный эзофагит, ГЭРБ, рубцовая стриктура, ахалазия;
6. у детей: стенозы, ожоги, операции на пищеводе в анамнезе; дисфагия, слюнотечение, отказ от еды, апноэ при кормлении являются показанием к эзофагоскопии.

Гиперсаливация и невозможность глотать жидкость свидетельствуют о полной непроходимости пищевода, удушье, стридор и одышка — об аспирации или сдавлении трахеи.

### 3.2 Физикальное обследование при поступлении

**Осмотр при поступлении**

1. оториноларинголог: подтверждение или исключение инородного тела в полости рта и глотке;
2. хирург: признаки перфорации пищевода (подкожная эмфизема, отёк, инфильтрат шеи), осложнения со стороны желудка и кишечника;
3. аускультация лёгких: хрипы, признаки аспирации;
4. подозрение на инородное тело прямой кишки: пальцевое исследование.

Лихорадка и тахикардия настораживают в отношении осложнения. При длительно стоящем инородном теле пищевода и отсутствии торакального отделения пациента переводят в профильный стационар или вызывают специалиста.

### 3.3 Лабораторные исследования: анализы крови

**При поступлении**

1. общий анализ крови;
2. биохимический анализ крови: глюкоза, мочевина, креатинин, амилаза, билирубин, АЛТ, АСТ.

**По показаниям**

1. калий, натрий, тромбоциты;
2. АЧТВ, МНО, фибринолитическая активность;
3. группа крови и резус-фактор.

### 3.4 Рентгенография

При подозрении на рентгеноконтрастное инородное тело или если характер инородного тела неизвестен, выполняется неотложная рентгенография мягких тканей шеи, органов грудной клетки и брюшной полости.

Сначала выполняют снимок в прямой проекции; ложноотрицательные результаты достигают 47%, поэтому при отрицательном результате дополнительно выполняют боковую проекцию. Для шейного отдела пищевода выполняют снимок шеи в боковой и прямой проекции с приподнятой головой.

Детям с подозрением на проглатывание инородного тела, даже без симптомов, показана неотложная рентгенография шеи, грудной клетки и брюшной полости, по показаниям также таза, в 2 проекциях.

При застрявшем пищевом комке без костей и без признаков осложнений обзорная рентгенография, как правило, не рекомендуется: ложноотрицательные результаты достигают 87%.

### 3.5 Рентгеноскопия с контрастом

При подозрении на обтурацию или перфорацию пищевода, рентгенонегативном инородном теле, сомнениях в локализации выполняется рентгеноскопия глотки и пищевода с водорастворимым йодсодержащим контрастом. Исследование не должно задерживать эндоскопию.

Контраст дают малыми порциями. При нарушении глотания (инородное тело на уровне глоточно-пищеводного перехода, неврологические заболевания) йодсодержащий контраст не применяют из-за риска аспирации и отёка лёгких.

Применение бария сульфата не рекомендуется: он опасен аспирацией и затрудняет последующую эндоскопию.

### 3.6 Компьютерная томография

При клинической картине перфорации пищевода, флегмоны шеи, медиастинита и других осложнений выполняется КТ органов грудной и брюшной полости.

Рыбьи кости — частые инородные тела у взрослых, застревают в верхней части пищевода; чувствительность рентгенографии составляет 32%, КТ — 90–100%. У детей КТ выполняют при рентгенонегативных инородных телах. Свободный газ под диафрагмой при перфорации инородным телом — ненадёжный признак.

### 3.7 Эндоскопия

Перед эндоскопией анализируют клиническую картину и данные лучевых исследований, чтобы выбрать обезболивание, эндоскоп и инструменты.

Всем пациентам с подозрением на инородное тело верхних отделов пищеварительного тракта показана ЭГДС, в том числе при отрицательном результате рентгенографии; она же является первым этапом лечебного вмешательства. У детей инородное тело пищевода удаляют **менее чем через 24 часа**.

При подозрении на инородное тело прямой или сигмовидной кишки выполняется ректороманоскопия.

### 3.8 Дифференциальная диагностика

**Сходная клиническая картина наблюдается при**

1. кандидозном, рефлюкс- и эозинофильном эзофагите;
2. ахалазии кардии;
3. после инсульта, в дебюте рассеянного склероза, БАС, миастении;
4. опухоли пищевода;
5. истерии и других заболеваниях нервной системы.

При интенсивной боли за грудиной необходимо исключить острый коронарный синдром, при инородном теле желудка и кишки — заболевания с картиной острого живота.

---

## 4. Лечение

### 4.1 Сроки эндоскопии

**Сроки эндоскопического вмешательства: экстренно — лучше в течение 2 часов, не позднее 6; срочно — в течение 24 часов; отсроченно — в течение 72 часов**

| Инородное тело | Пищевод | Желудок, тонкая кишка |
|---|---|---|
| **батарейка** | экстренно | срочно |
| **магнит** | срочно | срочно |
| **остроконечное** | экстренно | срочно |
| **тупое, менее 2–2,5 см** | срочно | отсроченно |
| **тупое, 2–2,5–5 см** | срочно | отсроченно (в тексте КР — в течение 24–48 часов) |
| **большое, более 5–6 см** | срочно | срочно |
| **дисковая батарейка у ребёнка (текст КР, раздел 3)** | экстренно | лучше в течение 12 часов, не позднее 24 часов |
| **пищевой комок** | экстренно (срочно — без симптомов и полной обструкции) | — |

### 4.2 Консервативное ведение

Наблюдение без извлечения допустимо, если инородное тело находится вне пищевода, симптомов нет, оно тупое, инертное и небольшое (**до 2–2,5 см в диаметре или 5 см в длину**).

После пищевода большинство инородных тел проходит ЖКТ за **4–6 дней**, редко — до 4 недель; через привратник не проходят предметы более 2–2,5 см, через изгиб ДПК — длиннее 5–6 см. Без симптомов при инородном теле желудка меньше этих размеров возможно амбулаторное наблюдение: пациента предупреждают о симптомах перфорации и непроходимости.

При наблюдении за небольшим тупым рентгеноконтрастным инородным телом проводится периодический рентгенологический контроль, при отсутствии симптомов еженедельно. Если инородное тело не вышло из желудка **за 3–4 недели**, его удаляют эндоскопически.

При контейнерах с наркотиками без симптомов необходимы пристальное наблюдение в стационаре, лаваж кишечника и рентгенологический контроль; эндоскопически контейнеры не удаляют.

При безоаре желудка сначала применяют 5–10% раствор пищевой соды или напитки с ортофосфорной кислотой, которые размягчают растительные безоары; их приём продолжают между сеансами эндоскопии.

**Консервативное ведение противопоказано**

1. магниты и батарейки;
2. остроконечные инородные тела;
3. безоары, силикагелевые шарики;
4. любые длительно стоящие инородные тела пищевода.

Магнит удаляют, даже если на снимке он один.

### 4.3 Эндоскопическое лечение

Перед удалением анализируют анамнез, клиническую картину, данные лучевых исследований и эндоскопическую картину, чтобы выбрать обезболивание, эндоскоп и инструменты.

Экстренное удаление (**лучше в течение 2 часов, не позднее 6**) показано при полной обструкции пищевода, остроконечных предметах и батарейках в пищеводе. Остальные инородные тела пищевода, в том числе магниты, удаляют срочно (**в течение 24 часов**).

Остроконечные предметы перфорируют до 35% случаев. Дисковая батарейка быстро повреждает пищевод: электрический ожог, утечка щелочи, пролежень. Риск тяжёлых осложнений при инородном теле в пищеводе **более 24 часов** выше в 14,1 раза.

Из желудка и проксимальной части ДПК у детей с симптомами остроконечные, крупные инородные тела, магниты и батарейки удаляют экстренно (**в первые 2 часа**); у взрослых, а также у детей без симптомов (магниты) — срочно (**в течение 24 часов**).

**Сроки удаления инородных тел желудка**

1. дисковые батарейки у детей независимо от симптомов, размера и количества: **лучше в течение 12 часов, не позднее 24**; после 12 часов риск осложнений возрастает в 4,5 раза;
2. инородные тела более 2–2,5 см: **в течение 24–48 часов** (в таблице 3 КР — отсроченно, в течение 72 часов);
3. тупое небольшое инородное тело, не покинувшее желудок **за 3–4 недели** (желательно не более 1 недели): эндоскопическое извлечение.

Цилиндрическую батарейку у ребёнка в пищеводе удаляют экстренно (**лучше в течение 2 часов, не позднее 6**), в других отделах пищеварительного тракта — как можно быстрее.

Крупные инородные тела прямой кишки удаляют экстренно, особенно у детей: под наркозом после девульсии ануса, зажимами Кохера.

Удаление выполняют под общим обезболиванием; у детей только под наркозом с интубацией трахеи (или внутривенно с сохранением спонтанного дыхания, глубокая седация). У взрослых нетравмоопасные инородные тела удаляют под внутривенной анестезией или седацией, при невозможности под местной анестезией.

Методом выбора является гибкая видеоэндоскопия: успех более 95%, осложнения 0–5%. Ригидную эзофагоскопию применяют только при инородном теле в верхней трети пищевода, которое не удаётся извлечь гибким эндоскопом, при перфорации в операционной перед дренированием средостения или если гибкой эндоскопии нет.

Длительно стоящее инородное тело или прежние безуспешные попытки — в операционной с инсуффляцией углекислого газа. Раскрытую булавку проводят в желудок, разворачивают и извлекают; острый конец направляют дистально; длинный предмет захватывают за кончик.

При остроконечных инородных телах используют защитные устройства: дистальный колпачок, конус, тубус (для инородных тел дистальнее пищевода длиной 45–60 см).

Специальные инструменты по типу инородного тела: щипцы «зуб крысы», «зуб аллигатора», полипэктомические петли, корзины, сетчатые ловушки; биопсийные щипцы не рекомендуются.

**Инструменты для извлечения у взрослых**

| Тип | Инструменты |
|---|---|
| **тупые** | щипцы-ретракторы, захваты, полипэктомические петли, корзинки, сетчатые ловушки |
| **остроконечные** | щипцы-ретракторы, петли, корзинки, сетчатые ловушки; прозрачный колпачок, латексный конус |
| **длинные** | полипэктомические петли, корзинки |
| **пищевые комки** | щипцы-ретракторы, захваты, петли, корзинки, сетчатые ловушки |

Пищевой комок осторожно низводят в желудок; если это не удаётся, его извлекают целиком или по частям. При значительном сопротивлении проталкивание прекращают.

Эндоскопическое удаление контейнера с наркотиками не рекомендуется: разрыв ведёт к тяжёлой интоксикации и смерти.

При перфорации с флегмоной, медиастинитом, перитонитом изолированное эндоскопическое удаление противопоказано; оно возможно в операционной во время хирургического вмешательства.

Попытки извлечения прекращают при неостанавливаемом кровотечении и если дальнейшие попытки под наркозом увеличивают риск повреждения стенки (рыболовный крючок, проволока «егоза»).

После извлечения обязательно осматривают место фиксации и путь извлечения, оценивают повреждение стенки.

При «свежей» перфорации пищевода (**до 6 часов**) выполняют эндоскопическое клипирование с инсуффляцией углекислого газа. После ушивания целесообразно установить зонд в желудок для питания пациента.

После вклинения пищевого комка или задержки тупого инородного тела необходимо обследовать место задержки для выявления стриктуры, эозинофильного эзофагита, ахалазии, опухоли.

Патология пищевода — более чем у 75% пациентов с вклинением пищевого комка: стриктуры (более 50%), эозинофильный эзофагит (около 40%). При подозрении на эозинофильный эзофагит — биопсия из трёх третей пищевода. Стриктуры и кольца Шацкого можно расширить сразу; при повреждении слизистой — ингибиторы протонного насоса и дилатация через 2–4 недели.

### 4.4 После удаления

При значительном повреждении слизистой оболочки или глубоком ранении острым предметом выполняют рентгеноскопию с водорастворимым контрастом для исключения перфорации. Поздняя перфорация от пролежня возможна **на 2–5-е сутки**.

Если при травме стенки пищевода с отёком инородное тело не найдено, после противовоспалительной терапии повторяют рентгеноскопию с контрастом и эзофагоскопию, особенно если проглочена рыбья кость.

При выраженном отёке слизистой оболочки пищевода назначают щадящую диету на **3–4 дня** (жидкая, прохладная пища), ибупрофен или парацетамол.

**Возможно также применение**

1. масляных растворов бета-каротина;
2. облепихового масла;
3. гиалуроновой кислоты;
4. ИПП.

При воспалении, изъязвлениях, трещинах прямой кишки применяют НПВП в суппозиториях.

При значительном повреждении слизистой оболочки или ушитой перфорации назначают короткий курс антибиотиков (цефалоспорины, пенициллины). Даже без перфорации показано наблюдение в стационаре **2–3 дня**.

При операции по поводу перфорации, флегмоны, медиастинита, перитонита антибиотики широкого спектра вводят внутривенно как можно раньше, предпочтительно резервные (карбапенемы).

### 4.5 Медикаментозная терапия

**Ибупрофен: детям до 6 лет по возрасту и массе тела, не более 30 мг/кг в сутки, интервал 6–8 часов**

1. 3–6 месяцев: по 50 мг 3 раза в сутки, не более 150 мг в сутки;
2. 6–12 месяцев: по 50 мг 3–4 раза в сутки, не более 200 мг в сутки;
3. 1–3 года: по 100 мг 3 раза в сутки, не более 300 мг в сутки;
4. 4–6 лет: по 150 мг 3 раза в сутки, не более 450 мг в сутки;
5. взрослые и дети старше 6 лет: 200–400 мг 3–4 раза в сутки; не более 800 мг в сутки в 6–12 лет, 1000 мг в 12–17 лет, 1200 мг у взрослых.

**Кетопрофен**

1. старше 15 лет: внутримышечно 100 мг 1–2 раза в сутки; внутривенно 100–200 мг в 100–150 мл 0,9% раствора натрия хлорида, только в стационаре.

**Парацетамол (противопоказан новорождённым)**

1. масса тела более 50 кг: 1 г до 4 раз в сутки;
2. масса тела 10–50 кг: 15 мг/кг до 4 раз в сутки;
3. масса тела до 10 кг: 7,5 мг/кг до 4 раз в сутки.

**Цефазолин, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон: профилактика хирургической инфекции, дозы по инструкции**

1. цефотаксим внутримышечно противопоказан детям **до 2,5 лет**;
2. цефтриаксон противопоказан недоношенным детям **до 41 недели**.

Оксациллин, амоксициллин + клавулановая кислота — дозы по инструкции; амоксициллин + клавулановая кислота противопоказан детям **до 2 лет**.

### 4.6 Хирургическое лечение

**Показания к операции**

1. инородное тело не удалось извлечь эндоскопически;
2. длительно стоящее в тонкой кишке, не извлекаемое при энтероскопии;
3. перфорация с флегмоной, медиастинитом, перитонитом;
4. тонкокишечная непроходимость;
5. кровотечение, не останавливаемое эндоскопически.

Опасное инородное тело за связкой Трейца, не продвигающееся **3 дня**, — рассмотреть операцию; видеокапсула — задержка в тонкой кишке **более 2 недель**.

При контейнерах с наркотиками операция показана при подозрении на нарушение упаковки, отсутствии продвижения, кишечной непроходимости.

Объём операции определяется локализацией инородного тела и осложнениями. Если перфорация пищевода произошла **более 6 часов** назад, как правило, уже развился медиастинит.

**Операция при перфорации пищевода**

1. торакотомия, медиастинотомия;
2. удаление инородного тела, ушивание пищевода;
3. дренирование средостения и плевральной полости.

Гастростомия показана при технических трудностях ушивания перфорации пищевода, если уже развились гнойно-септические осложнения, в частности гнойный медиастинит.

При перфорации прямой кишки на всю толщину накладывают защитную колостому.

**Диаметр пищевода по возрасту**

| Возраст | Диаметр пищевода |
|---|---|
| **новорождённый** | 5–6 мм |
| **6 месяцев** | 8–9 мм |
| **1 год** | 12 мм |
| **3–6 лет** | 13–15 мм |
| **15 лет** | 18–19 мм |
| **взрослый** | 20–22 мм |

**Эндоскопы для верхних отделов у детей**

| Масса ребёнка | Эндоскоп, мм | Канал, мм |
|---|---|---|
| **новорождённые и младенцы до 10 кг** | 4,9–5,9 | 2,0–2,2 |
| **от 10 кг** | 7,8–9,2 | 2,2–2,8 |
| **более 25 кг — стандартные взрослые эндоскопы** | 9,2–9,9 и более | 2,8–3,7 |

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

### 5.1 Организация помощи и госпитализация

При подозрении на инородное тело пищевода в поликлинике выполняют обзорную рентгенограмму шейного отдела пищевода и направляют пациента в стационар с оториноларингологом и эндоскопической службой.

**Не рекомендуется**

1. вызывать рвоту и «проталкивать» инородное тело жёсткой пищей;
2. промывать пищевод и желудок на дому.

Все пациенты госпитализируются в многопрофильный стационар с круглосуточной эндоскопической службой; при аспирации, перитоните, кишечной непроходимости — в ОРИТ.

При тупом инертном инородном теле до 2–2,5 см без симптомов допустимо амбулаторное наблюдение. После успешного удаления без осложнений и без серьёзного повреждения стенки пациента выписывают сразу.

**Показания к госпитализации для наблюдения**

1. технически сложное извлечение;
2. несколько предметов, остроконечные, батарейки, магниты, предметы более 5–6 см;
3. обширное повреждение слизистой;
4. травма пищевода 3–5 степени;
5. травма стенки без найденного инородного тела; патология пищевода, имитировавшая инородное тело.

Если острые предметы не извлечены, рентгенографию выполняют ежедневно, при батарейках дистальнее ДПК — каждые 3–4 дня.

При травме стенки пищевода пациента выписывают только после контрольной прицельной рентгенографии органов грудной клетки и эзофагоскопии.

**Травмы пищевода (видоизменённая классификация Bassett, 1980)**

| Степень | Эндоскопическая картина |
|---|---|
| 1 | отёк и гиперемия слизистой, обилие слизи (катаральный эзофагит) |
| 2 | одиночные царапины, повреждены только верхние слои слизистой |
| 3 | значительный отёк, мелкие подслизистые кровоизлияния, скудное кровотечение — повреждена вся толща слизистой |
| 4 | слизистая разрушена на значительном протяжении, большие подслизистые гематомы, фибрин, контактная кровоточивость |
| 5 | глубокие слепые ранения со слизистой на подслизистый слой, отслойка слизистой 1–2 см, пролежень — повреждён внутренний мышечный слой |
| 6 | перфорация, глубокое непроникающее ранение с обильным кровотечением |

### 5.2 Реабилитация и профилактика

После осложнений и операций реабилитацию проводят с учётом осложнения и вида операции; после самостоятельного отхождения или неосложнённого эндоскопического удаления специальная реабилитация, как правило, не нужна.

Родителям следует разъяснять недопустимость оставлять детей без присмотра.

При трихобезоаре необходимо наблюдение психиатра и (или) невролога, ЭГДС **каждые 6–12 месяцев в течение 2–3 лет**.

Лечение заболевания пищевода, вызвавшего вклинение пищевого комка: стриктура, эозинофильный эзофагит, опухоль.

Исход во многом определяет состояние пищевода: опухоли, ахалазия, дивертикулы, ожоговые стриктуры, эзофагит, врождённая патология; тактика определяется индивидуально.

---

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Инородное тело в пищеварительном тракте» |
| Версия | 2-я, опубликована в рубрикаторе 17.10.2024 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года |
| Код в рубрикаторе | `710_2` · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Российская ассоциация детских хирургов; Российское общество хирургов; Российское общество рентгенологов и радиологов; Эндоскопическое общество «РЭндО» |
| Пациенты | Взрослые и дети |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки удаления тупых инородных тел желудка 2–2,5–5 см различаются: в таблице 3 (приложение А3) — «отсроченно», то есть в течение 72 часов, в тексте раздела 3 — «в течение 24-48 часов от поступления». На странице приведены оба срока.